

PROTOCOLO DE ABSCESO / FLEMÓN PERIAMIGDALINO

Unidad de Observación de Media Estancia (UOME)

1. OBJETIVO

Establecer un protocolo de actuación para pacientes diagnosticados en Urgencias de absceso o flemón periamigdalino subsidiarios de manejo en UOME mediante observación clínica, antibioterapia intravenosa, analgesia, hidratación y vigilancia de la vía aérea hasta **valoración obligatoria por ORL**.

2. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DESDE URGENCIAS

- Diagnóstico clínico de absceso o flemón periamigdalino.
- Necesidad de antibioterapia IV.
- Necesidad de analgesia e hidratación IV.
- Estabilidad hemodinámica y ausencia de criterios de sepsis.
- $\text{SatO}_2 \geq 94\%$.
- Ausencia de compromiso inmediato de vía aérea.
- Previsible estabilidad clínica durante estancia ≤ 36 h.

3. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN / INGRESO DIRECTO

Valoración ORL urgente:.

- Compromiso de vía aérea, disnea o estridor.
- Imposibilidad para manejar secreciones.
- Sospecha de absceso cervical profundo.
- Extensión parafaríngea o retrofaríngea.
- Trismus severo progresivo.

Ingreso en Medicina Interna:

- Sepsis o shock séptico.
- Inmunosupresión grave.
- Neutropenia.
- Fragilidad severa.

4. EVALUACIÓN INICIAL EN UOME

Constantes: TA, FC, FR, SatO₂ y T^a.

Analítica: hemograma, bioquímica con PCR y coagulación.

Valorar: trismus, tolerancia oral, manejo de secreciones, aparición de voz de 'patata caliente' y signos de compromiso respiratorio.

5. CONTROL EVOLUTIVO

Constantes cada **4 horas** durante las primeras 12 horas y posteriormente cada **8 horas** si estabilidad hemodinámica y buena evolución clínica.

Reevaluación médica a las 6–8 horas y a las 24 horas.

6. CONTROL ANALÍTICO

No precisa control rutinario en todos los pacientes.

Repetir a las 12–24 horas si fiebre persistente, mala evolución, PCR muy elevada o sospecha de complicación.

7. PRUEBAS DE IMAGEN

No necesarias de forma rutinaria.

TC cervical con contraste si sospecha de extensión profunda, mala evolución o duda diagnóstica.

8. TRATAMIENTO GENERAL

Reposo relativo.

Hidratación IV: SF 0,9% 500–1000 ml iniciales y posteriormente 80–125 ml/h según situación clínica.

Dieta según tolerancia: blanda, turmix o absoluta con sueros habituales según comorbilidades.

9. ANALGESIA Y CORTICOTERAPIA

- Paracetamol 1 g IV cada 8 h.
- Metamizol 2 g IV cada 8 h si precisa por dolor o fiebre.
- Opiáceos IV si dolor refractario.
- Dexametasona 8 mg IV dosis inicial. Valorar nuevas dosis según evolución y criterio ORL.

10. ANTIBIOTERAPIA EMPÍRICA

Primera elección:

- Amoxicilina-clavulánico 1 g IV cada 8 h.

Alergia a betalactámicos:

- Clindamicina 600 mg IV cada 8 h.

11. CONTROLES DE ENFERMERÍA

- Control de constantes y registro de temperatura según protocolo.
- Registro del dolor (0–10).
- Vigilancia de tolerancia oral.
- Vigilancia de capacidad para deglutir saliva.
- Vigilancia de cambios en la voz y evolución del trismus.
- Vigilancia respiratoria.

Signos de alarma:

- Estridor.
- Disnea.
- $\text{SatO}_2 < 94\%$.
- Empeoramiento del trismus.
- Deterioro clínico.

12. VALORACIÓN POR ORL

Todos los pacientes deberán ser valorados por ORL durante su estancia en UOME. La valoración determinará necesidad de drenaje, tratamiento conservador, alta o ingreso.

13. DESTINO EVOLUTIVO

Alta domiciliaria:

- Mejoría clínica.
- Tolerancia oral.
- Dolor controlado.
- Valoración favorable por ORL.

Ingreso ORL:

- Necesidad de drenaje.
- Persistencia del absceso.
- Mala evolución.

Ingreso Medicina Interna:

- Sepsis/paciente complejo por comorbilidades.

14. TRATAMIENTO AL ALTA

- Amoxicilina-clavulánico 875/125 mg VO cada 8 h.
- Clindamicina 300–450 mg VO cada 6–8 h en alérgicos.

Duración total habitual: 10–14 días.

Analgesia: Paracetamol 1 g VO cada 8 h $\pm$ Metamizol 575 mg VO si precisa, alternando con AINES

15. RECOMENDACIONES AL ALTA

Reconsulta inmediata por disnea, estridor, imposibilidad para deglutir, fiebre persistente o empeoramiento del dolor. Mantener hidratación adecuada y completar antibioterapia.

16. BIBLIOGRAFÍA

1. UpToDate. Peritonsillar Cellulitis and Peritonsillar Abscess in Adults.
2. AAO-HNS Clinical Guidance.
3. SIGN Guidelines.
4. PROA-SEIMC / PRAN.
5. Revisiones actuales de absceso periamigdalino en ORL.